INDICADO POR:
( )ACOMPANHAMENTO ( )CONSULTA
NS

HUGO CHAVES DE SOUSA

IDADE: 80	PESO: 70	ALTURA: 170	PROFISSÃO: Policial (aposentado)

SINTOMAS: Sonolência diurna / Refluxo gástrico.

QUEIXAS: Dificuld p/ pegar no sono. / Nota 60 p/ sono / Dorme DLD

MEDICAMENTOS:

HAS / Depressão / Memória Ruim / Deficiente Aud.

MÉDICO: Drº. Pedro Macedo.

MARCAPASSO: ( )S ( )N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: ( )S ( )N

EXERCÍCIO FÍSICO: Voley Adaptado (2x)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S (21) JANTAR: —

HORA QUE DORME: 23 HORA QUE ACORDA: 9hs

COCHILO ( )S (X)N DORME ACOMPANHADO: (X)S ( )N ( )EVENTUALMENTE esposa não pouco

TEM FILHOS: ( )S (X)N / DORMEM NO QUARTO: ( )S (X)N PET NO QUARTO: ( )S (X)N

BEBIDA ALCOÓLICA: (X)S ( ) X NA SEMANA ( )N Só FS.

FUMO: ( )S ( ) MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal	BANHEIRO/NOITE: 1 a 2X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal	CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH:	SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Dor lombar e clavícula

CIRURGIAS: (N)NASAL (N)AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Não

COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (N)ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S)ORTOPÉDICA	(S)NEUROLÓGICA	( )OUTROS:

POLISSONOGRAFIA COM CPAP: ( )S ( )N	SPO2 C/ CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:

23/07/25 Avaliação

Marc Miraz Fx

Descrição do Exame Polissonográfico

IUGO CHAVES DE SOUSA			
	Idade: **80 anos**	Peso: **72 Kg**	Altura: **1.70 m**
.9	Data do Exame: **17/06/2025**	Exame: **00669_01**	

ITÁRIOS:

Exame iniciado às 9:01:10 PM horas e encerrado às 6:02:10 AM horas, com latência para o sono de 97 ; e latência para o sono REM de 375 minutos. O tempo total de sono foi de 419.5 minutos, com eficiência) de 77.3%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	**0.6%**	Até 5%
Estágio 2	**92.7%**	45 - 55%
Estágio 3	**2.5%**	> 15%
Sono REM	**4.2%**	20 - 25%
Eficiência do sono	**77.3%**	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 25.5 minutos ocorreram **182 despertares (índice de /hora).**

Durante o registro, a freqüência cardíaca média foi de 65 bpm, a maior de 76 bpm e a menor de 59 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a spertares.**

Ocorreram 192 eventos respiratórios, sendo 0 central e 192 obstrutivos. Sendo 184 apnéias, 8 hipopnéias) RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 27.4/hora**, sendo 26.3 apnéia/hora e 1.1 opnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 20.3 e a duração máxima de .7.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 24.0/hora, sendo 24.0 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O dice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração áxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **95%**, sendo a saturação **média de 94%**, a **maior de 98%** e **mínima de 85%**, permanecendo 1.7 minutos (0.3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos).0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 194 dessaturações. Índice de dessaturações: 29.3/hora. Índice e dessaturações no sono REM: 21.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 30.0/hora.

Resumo dos resultados

1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
3 - Ronco presente.
4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
5 - Eficiência do sono reduzida.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264